

Généralités Abord et examen clinique d'un patient 2ème partie

Objectifs du cours:

- ✓ Comprendre le déroulement d'un examen clinique:
- ✓ Identifier les quatre temps essentiels de l'examen physique:
Inspection, palpation, percussion, auscultation.
- ✓ Distinguer un examen clinique normal d'un examen clinique pathologique.
- ✓ Initiation aux gestes pratiques simples.

Plan du cours:

- I. Règles générales de l'examen physique
- II. Matériel pour l'examen physique
- III. Les techniques de base de l'examen physique
- IV. Séquence de l'examen physique

I. Règles générales de l'examen physique

l'examen physique est mené :

Dans une pièce correctement chauffée et éclairée
chez un patient rassuré, informé du déroulement de l'examen

Mettre le patient en **confiance**

l' Installer **confortablement** sur la table de consultation

Patient **déshabillé**

Avec respect de **son intimité et sa pudeur** : drap blanc

le respect de la **confidentialité**

Un environnement **silencieux**

la disponibilité du médecin

L'examineur étant placé **à droite du patient** et utilise sa main droite pour la plus part des manœuvres

lavage des mains, avant et après l'examen

II. Matériel pour l'examen physique

- Blouse blanche
- Matériel nécessaire:

Stéthoscope : Auscultation

Appareil de mesure de la pression artérielle

Thermomètre: Mesure de la température corporelle

Marteau à reflexe: Tester les reflexes ostéo-tendineux

Diapason 128 Hz: Tester la sensibilité vibratoire (pallesthésie)

Mètre ruban, abaisse langue, lampe de poche

Montre marquant les secondes: Mesure de la fréquence cardiaque et respiratoire
Pèse personne, toise: poids/ taille et calcul du BMI
Bandelettes : Analyse d'urine
Gant et lubrifiant: Toucher rectal
Coton, tubes à essais, épingles à nourrices : Tester la sensibilité superficielle
Oto-ophtalmoscope si possible
Stylo, papier.

III. Les techniques de base de l'examen

Notez que l'examen physique pour chaque système ou organe comprend successivement: :

1. **Inspection**
2. **Palpation**
3. **Percussion**
4. **Auscultation**

1. **Inspection** : *très riche en information*

l'examinateur doit s'entraîner à observer, "apprendre à l'œil à voir".

Observation minutieuse de l'aspect général du patient, son état de conscience, sa posture, sa démarche, son comportement, son humeur, sa mimique, sa peau, son état nutritionnel, les mouvements oculaires, la symétrie de son thorax, les contours de l'abdomen, présence d'un œdème des membres inférieurs, d'un hippocratisme digital, d'un phénomène de Raynaud, d'une érythrose palmaire.

Bien connaître certaines attitudes:

l'asymétrie du visage en cas de paralysie faciale

la marche en fauchant de l'hémiplégique, l'aspect soudé du parkinsonien

le goitre, l'exophtalmie, l'agitation du basedowien; le faciès infiltré de l'hypothyroïdien

le faciès lunaire et l'obésité tronculaire du syndrome de cushing.

Bien observer la position du malade:

le cirrhotique est couché sur le dos

le cardiaque est assis sur le lit, avec des oreillers, cyanosé et turgescence des jugulaires

l'artéritique est assis les jambes pendantes

le pleurétique est couché sur le côté malade, il a une toux sèche et brève.

2. **Palpation** : *est l'utilisation du sens tactile, le toucher*

Il s'agit d'une pression exercée avec:

- **la face palmaire de la main:** pour palper un choc apexien, rechercher un frémissement cardiaque, apprécier la transmission des vibrations vocales.
- **ou la pulpe des doigts:** pour palper une pulsation vasculaire
- **ou la face palmaire de la pulpe des doigts:** pour déterminer le contour et la taille d'un organe profond (rate, foie), de la glande thyroïde, les caractéristiques d'une tuméfaction, des adénopathies, d'une zone douloureuse.

3. **Percussion**: **2 techniques** : percussion médiate et percussion immédiate.

Percussion immédiate ou directe: se fait par un coup sec à l'aide d'un doigt ou plusieurs doigts réunis de l'examinateur sur la surface à examiner.

Percussion médiate: l'utilisation d'un doigt (doigt percuteur), en général le médius droit, pour **frapper brièvement: "percuter "**extrémité distal d'un doigt de l'autre main posé sur la surface du thorax ou de l'abdomen.

Résultat: la sensation tactile du son produit, telle qu'une **sonorité ou matité** (air, liquide) nous renseigne sur la structure des organes ou des tissus sous jacents.

- la percussion sur un organe solide: tel que le foie: produit un son mat
- la percussion dans une structure contenant l'air: tel que le poumon: produit une sonorité
- la percussion dans une structure creuse contenant l'air: tel que l'estomac: produit un son tympanique.

Ex : la percussion d'une matité sur la partie médiane basse de l'abdomen est probablement celle d'une vessie pleine.

4. Auscultation:

C'est l'écoute de son produit par les organes internes à l'aide d'un **stéthoscope**.

On ausculte le **cœur**, les **poumons** et les **artères** (l'aorte abdominale, carotides, artères rénales).

- **le cœur:** on déplace le stéthoscope de proche en proche en partant de la pointe vers la base, on identifie les **bruits cardiaques normaux (B1, B2)** correspondant à la fermeture des valves, on recherche également les bruits surajoutés, les souffles , un frottement ou un assourdissement des bruits: dû à une péricardite.
- **les poumons:** l'auscultation se fait de manière comparative au niveau des 2 hémithorax de haut en bas , sur la face antérieure, postérieure et latérale, on demande au patient de respirer par la bouche (respiration lente et profond), elle permet d'évaluer le passage de l'air dans l'arbre trachéo-bronchique.

On peut ausculter également l'abdomen: absence de bruit intestinaux normaux peut traduire une urgence chirurgicale.

IV. Séquence de l'examen physique

l'examen est réalisé de façon méthodique et organisé de la tête aux pieds en expliquant au fur et à mesure les différentes manœuvres au patient.

On commence toujours par apprécier l'état général, les constantes vitales puis l'examen de la peau ensuite l'examen appareil par appareil.

l'état général:

Appréciation générale sur l'état de santé apparent: bon , moyen ou altéré

L'état de conscience

Evaluation des constantes hémodynamiques: FC, FR, TA T°C

La température: à la recherche d'un syndrome infectieux

Si fièvre: établir la courbe de température

L'état d'hydratation: signes de déshydratation

L'état nutritionnel: poids / taille et calcul du BMI

La peau, les muqueuses et les téguments: pâleur, cyanose, ictère, mélanodermie

Recherche de lésions cutanées: nodules, érythème, vergetures

Des cicatrices chirurgicales

D'un hippocratisme digital

D'un syndrome œdémateux : signe de godet

D'un syndrome hémorragique: purpura, ecchymoses

Examen De La Tête:

Examen de la peau: sa coloration, sa pigmentation, sa texture, son infiltration

Recherchez une asymétrie

l' Aspect des phanères: ex: cheveux fins et cassants, une alopecie, une chute de la queue de sourcils).

Examen de yeux:

- ✓ Examen des conjonctives: pâle, ictère
- ✓ Xanthélasmas: hyperlipémie
- ✓ Exophtalmie
- ✓ Ptosis, Strabisme

Examen de la cavité buccale:

comprend: la muqueuse buccale, les lèvres, la langue, voile du palais, dents, glande salivaires.

Examen de la langue:

- ✓ Humide et rosée à l'état normal
- ✓ Blanche et saburrale dans certaines infections
- ✓ Sèche, rôtie : déshydratations
- ✓ Lisse dépapillée: Biermer: glossite de Hunter
- ✓ Rouge, luisante: cirrhose
- ✓ Macroglossie: hypothyroïdie, amylose

Examen des dents:

- ✓ Modifications morphologiques, chute précoce, caries.

Examen de la face interne des joues:

- ✓ Signe de Koplick de la rougeole
- ✓ Taches ardoisées en cas d'insuffisance surrénale
- ✓ tache blanchâtre: Leucoplasie ou lichen.

Examen du pharynx:

Amygdales : volume, couleur, exsudats, fausses membranes
Voile du palais.

Examen du cou

Nous renseigne sur :

- ✓ la glande thyroïde
- ✓ Présence d'adénopathies cervicales, masse cervicale
- ✓ gros vaisseaux: artères carotides et veines jugulaires.

Inspection:

Elargissement de la base du cou: goitre

Saillie latérale: Adénopathie

Battement exagéré des carotides, turgescence des jugulaires

Palpation: examen de la thyroïde et palpation des aires ganglionnaires

auscultation: des artères carotides.

Examen du thorax

Le torse doit être nu, il inclut l'examen cardiaque avec le système vasculaire périphérique, l'examen respiratoire, l'examen des seins et le creux des aisselles.

L'inspection recherche : une asymétrie thoracique, les modifications du rachis: cyphose, scoliose, une circulation veineuse collatérale (CVC), un œdème en pèlerine évoquant un syndrome cave supérieur, des angiomes stellaires, une gynécomastie unilatérale: cancer du poumon, un comblement des creux sus claviculaires, d'une adénopathie (ganglion de Troisier).

l'examen de l'appareil cardio-vasculaire normal, note: le choc apexien est au niveau du 5^{ème} EIC gauche, B1B2 (bruits du cœur normaux) audibles aux quatre foyers, pas de souffles, pas de galop, pas de frottement.

l'examen respiratoire normal, note: un thorax symétrique, une bonne ampliation thoracique, poumons sonores, murmure vésiculaire audible, pas de râles ni sifflements.

Examen des seins :

l'inspection: se fait sur la malade dévêtue jusqu'à la ceinture, en position assise face à l'examineur, les mains posées sur les genoux, puis les bras levés au dessus de la tête, de manière comparative.

la palpation: se fait sur la malade assise les bras baissées, puis les bras levés au dessus de la tête et en position couchée, la palpation se pratique avec la pulpe des doigts dans un mouvement rotatoire de va et de vient, explorant chaque quadrant.

la palpation des creux axillaires et sus claviculaires est systématique à la recherche d'adénopathies.

Résultat: à l'état pathologique, les seins peuvent être le siège de différents remaniements pathologiques : abcès, tumeurs, gynécomastie.

✓ *Gynécomastie* : hypertrophie mammaire chez l'homme.

Examen de l'abdomen

Patient en position de décubitus dorsal, relâché, la tête reposant sur le lit, les membres inférieurs demi-fléchies.

S'asseoir à droite du malade.

L'Inspection: apprécie le volume de l'abdomen, recherche une voussure, une dépression, une hernie ombilicale, une CVC.

La palpation : est l'étape essentielle de l'examen

elle apprécie : le tonus de la paroi abdominale: à l'état normal : la paroi est souple, la présence d'une défense ou contracture correspond à une irritation péritonéale.

Elle recherche: une hypertrophie d'un viscère, la présence d'une hernie, d'une tumeur, l'existence de points douloureux particuliers: point vésiculaire par la manœuvre de Murphy.

La percussion: En décubitus dorsal, elle doit être douce.

Chez le sujet normal: permet de délimiter le bord supérieur et inférieur de la matité hépatique pour le calcul de la flèche hépatique, par ailleurs l'abdomen est sonore.

les anomalies: matité déclive évoquant une ascite.

L'auscultation: apporte peu de renseignements, peut mettre en évidence:

un silence auscultatoire: au cours de l'occlusion intestinale

un souffle: en cas de compression vasculaire ou d'anévrisme de l'aorte abdominale.

Examen de l'appareil urinaire:

Doit comporter un examen des fosses lombaires à la recherche d'un gros rein, de points douloureux urétéraux et la recherche d'un globe vésical.

Examen des régions inguino-crurales:

A la recherche d' hernies inguinales, hernies crurales, adénopathies.

Examen de la région anale:

Inspection :

- ✓ A la recherche : d' hémorroïdes externes, de fissures, de fistules, de condylomes.

Toucher rectal: réalisé avec un doigtier et lubrifiant

- ✓ On recherche: une douleur, des hémorroïdes internes, une tumeur rectale
- ✓ On apprécie l' état de la prostate, le sphincter anal, la couleur des selles: rectorragies, méléna.

Examen: ostéo-articulaire

l'examen se fait de façon symétrique

Des membres supérieurs et inférieurs, articulation par articulation

Du rachis cervical, dorsal, lombaire et du pelvis

On recherche: de signes inflammatoires articulaires, une raideur articulaire, les déformations osseuses, articulaires

On apprécie également la mobilité articulaire active, passive et contrariée.

Examen neurologique:

Apprécie: l'état de conscience, l'orientation temporo-spaciale et les fonctions supérieures

Explore: la station debout, la marche et l'équilibre

Explore les paires crâniennes

Etudie la sensibilité superficielle et profonde

Etudie la motricité, le tonus musculaire, les reflexes osteo-tendineux et le cutané-plantaire.

Bibliographie:

1. Sémiologie Médicale, Loïc Guillevin
2. Sémiologie Médicale. Examen clinique, Pr Malek Rachid CHU Sétif
3. Guide de l'examen clinique, Barbara Bates
4. Manuel de diagnostic clinique, Mark H. Swartz